KIT 2 – DOR TORÁCICA

Referências: ABRAMEDE 2024 • SBC 2023 • ACLS 2020 • Ministério da Saúde – Protocolos de Síndromes Coronarianas Agudas e Emergências Cardiovasculares

Objetivo

Padronizar a solicitação de exames laboratoriais e de imagem em pacientes com dor torácica no pronto-socorro, priorizando a estratificação de risco, a segurança diagnóstica e a racionalização de recursos laboratoriais e de imagem.

1. AVALIAÇÃO INICIAL – ABORDAGEM CLÍNICA E ESTRATIFICAÇÃO

- Avaliar **tempo de início, tipo e características da dor torácica** (localização, irradiação, duração, fatores de alívio/agravamento, sintomas associados).
- Realizar **ECG de 12 derivações imediato** em todos os casos.
- Classificar conforme **tipo de dor torácica** (ABRAMEDE / SBC):

Tipo de Dor	Características Clínicas	Suspeita Principal
Tipo A – Isquêmica típica	Dor retroesternal, em aperto, irradiando para braço, mandíbula ou dorso, com sudorese, náusea ou dispneia.	Síndrome Coronariana Aguda (SCA)
Tipo B – Isquêmica atípica	Dor epigástrica, dorsal, cervical, menos intensa ou não irradiada, mas com fatores de risco cardiovascular.	SCA / Isquemia atípica
Tipo C – Não cardíaca	Localizada, reproduzida à palpação, piora com movimento, sem sintomas vegetativos.	Dor musculoesquelética
Tipo D – Indeterminada / ansiosa	Mal definida, intermitente, sem padrão cardíaco ou pulmonar.	Psicogênica / funcional

2. EXAMES LABORATORIAIS

Exame	Indicação de Solicitação	Evitar / Não Indicado
Troponina de alta sensibilidade (0h e 3h)	Dor tipo A/B, sintomas < 12h, ECG com alteração isquêmica ou fatores de risco cardiovascular.	Dor musculoesquelética, psicogênica ou tipo C/D sem fator de risco.
CK-MB / CPK	Alternativa se troponina indisponível.	Não solicitar junto com troponina.
Hemograma completo	Suspeita de infecção (pneumonia, pericardite), anemia ou causa sistêmica.	Dor isolada de baixo risco sem repercussão sistêmica.
Ureia / Creatinina / Eletrólitos	Avaliação pré-contraste e risco renal em dor tipo A/B ou suspeita de TEP.	Casos leves, dor musculoesquelética.
Gasometria + Lactato	Instabilidade hemodinâmica, hipoxemia, suspeita de sepse ou TEP.	Casos leves com SpO_2 normal e estabilidade.
PCR / Procalcitonina	Suspeita de pneumonia, pericardite ou processo infeccioso.	Dor sem sinais infecciosos.

Exame	Indicação de Solicitação	Evitar / Não Indicado
BNP ou NT-proBNP	Dispneia, ortopneia, estertores, suspeita de insuficiência cardíaca aguda.	Dor torácica isolada sem congestão.
D-Dímero	Suspeita de TEP com **Escore de Wells ≤ 4** (baixo/intermediário).	Não solicitar de rotina; se Wells > 4 → realizar Angio-TC direto.
Glicemia capilar	Todo paciente com rebaixamento de consciência, sudorese ou confusão mental.	—

3. EXAMES DE IMAGEM

a) Radiografia e Ultrassonografia

Exame	Indicação	Evitar
ECG de 12 derivações	Todos os pacientes com dor torácica.	Nunca dispensar.
RX de Tórax (PA/AP)	Dispneia, febre, trauma torácico, suspeita de IC, pneumonia, pneumotórax ou dissecção de aorta.	Dor muscular ou psicogênica sem alterações clínicas.
USG / POCUS cardíaco e pulmonar	Avaliar função ventricular, tamponamento, congestão pulmonar, pneumotórax, derrame pleural.	Casos leves e estáveis sem sinais respiratórios ou hemodinâmicos.

b) Tomografia Computadorizada (TC)

TC	Indicação (Solicitar se)	Evitar / Não Indicado
TC de Tórax com contraste (Angio-TC)	Suspeita de TEP (Escore de Wells > 4 ou D-dímero positivo) ou dissecção de aorta (dor transfixante + PA diferencial + mediastino alargado).	Dor inespecífica, sem sinais clínicos ou laboratoriais sugestivos.
TC de Tórax sem contraste	Suspeita de lesão pulmonar (pneumotórax oculto, tumor, consolidação atípica).	Dor de origem cardíaca confirmada ou RX normal com clínica leve.

4. CRITÉRIOS DE APOIO À DECISÃO

Critério	Pontos
Sinais clínicos de TVP	3,0
TEP mais provável que outro diagnóstico	3,0
FC > 100 bpm	1,5
Cirurgia / imobilização recente	1,5
História prévia de TEP/TVP	1,5

Critério	Pontos
Hemoptise	1,0
Câncer ativo	1,0

Interpretação:

- ≤ 4 pontos → Baixo risco → Solicitar **D-Dímero**
    - 4 pontos → Alto risco → Solicitar **Angio-TC de Tórax**

5. PRIORIDADES

- Realizar **ECG e avaliação clínica imediata** antes de qualquer exame laboratorial.
- Solicitar **troponina seriada** apenas quando houver quadro compatível ou risco cardiovascular.
- Evitar duplicidade de exames (CKMB + troponina / RX + TC sem justificativa).
- Utilizar **critérios de risco e escores clínicos** antes de ampliar investigação.
- Sempre correlacionar **exame físico, ECG e tipo de dor** antes da decisão diagnóstica.

Resumo Prático:

Cenário	Exames Laboratoriais	Exames de Imagem
Dor Tipo A/B (suspeita cardíaca)	Troponina, eletrólitos, creatinina, ECG	RX Tórax ± Eco POCUS
Dispneia / IC descompensada	Troponina, BNP, gasometria	RX Tórax ± Eco POCUS
Suspeita de TEP	D-dímero (baixo risco) / Angio-TC (alto risco)	TC contrastada
Dor pleurítica / infecciosa	Hemograma, PCR, Procalcitonina	RX Tórax ± TC
Dor musculoesquelética / ansiosa	Nenhum exame necessário	Nenhum exame necessário

Conclusão

A avaliação racional da dor torácica reduz exames desnecessários, otimiza o diagnóstico precoce de síndromes graves (SCA, TEP, dissecção de aorta) e melhora o fluxo assistencial no pronto-socorro. O julgamento clínico deve prevalecer, com base em **critérios objetivos e diretrizes atualizadas**.

✅ Diagnóstico rápido e direcionado
✅ Menor sobrecarga laboratorial e radiológica
✅ Fluxo assistencial mais eficiente
✅ Redução de custos e tempo de permanência